马应龙战略转型与交易价值评估

——面向产业资本与 PE 的 CDD 报告

【报告属性】：公开信息阶段版本

【信息基准】：公司 2021-2025 年报、2026 年公开披露信息、估值模型、项目访谈提纲、市场行情截至 2026 年 10 月可检索数据

【报告用途】：支持投资初筛、交易假设形成、正式尽调范围设计及管理层访谈

【核心问题】：马应龙是一项以成熟中药 OTC 现金流为底座、以大健康业务为潜在增长期权、同时面临业务组合与少数股权结构复杂性的投资机会。交易价值不只取决于公司当前利润，更取决于买方能否验证第二曲线的增长质量，并将资本配置和业务组合调整转化为可兑现的股东回报。

【重要提示】：本报告不包含管理层、渠道商或行业专家的实际访谈结果；未获得的数据室信息均标记为“待验证”。

目　　录

一、执行摘要：投资判断与交易要点 1
（一）核心建议：有条件推进 1
（二）初步结论 1
（三）交易立场 1
（四）进一步尽调 1
二、标的信息与商业模式：现金流底座和业务组合 3
（一）公司定位：从肛肠药品龙头向健康方案提供商延伸 3
（二）业务组合与盈利结构 3
（三）财务快照与历史趋势 3
（四）商业模式与核心资产 4
（五）口径注意事项 4
三、核心治痔业务：品牌壁垒仍在，增长质量需要重新定价 5
（一）业务底盘：高毛利、强品牌，但增长并非没有边界 5
（二）2026H1 的关键问题：终端转弱还是渠道、结构扰动？ 5
（三）竞争壁垒的质量评估 5
（四）集采与合规风险：不能将豁免作为基准假设 5
（五）核心业务的估值含义 6
四、大健康第二曲线：渠道衍生品特征显著，消费品牌估值尚待证实 7
（一）增长规模：高增速有意义，但需区分规模与质量 7
（二）单品组合：从“明星产品”转向“品类经营能力” 7
（三）渠道与复购：自营占比不是复购质量的替代指标 7
（四）少数股权与治理：并表不等于享有全部经济权益 8
（五）大健康估值“升级”的证据门槛 8
五、战略转型与资本配置：从多业务布局走向资源聚焦 9
（一）战略转型的实质：资源分配，而非业务标签变化 9
（二）低毛利业务是否应该剥离：用资本回报而非毛利率判断 9
（三）现金、分红与再投资的权衡 9
（四）研发与创新：投入比例之外看项目组合 9
六、估值框架：整体 DCF、分部估值与交易价格 10
（一）估值原则：整体 DCF 用于校验，SOTP 用于解释价值来源 10
（二）对原 DCF 模型的关键审视 10
（三）分部估值（SOTP）建议框架 10
（四）估值情景与触发条件 11

（五）综合估值区间定性判断（Football Field 逻辑）.....11
（六）交易价格桥接：从上市公司市值到买方可支付价格.....11
七、交易策略：产业资本与 PE 的价值创造路径.....12
（一）产业资本：以协同兑现和资源重配为主.....12
（二）PE：先建立不依赖分拆的回报模型.....12
（三）交易结构的可选路径.....12
八、关键风险、证伪条件与正式尽调计划.....14
（一）风险矩阵.....14
（二）证伪条件：出现哪些事实应下调或终止投资判断.....14
（三）正式尽调工作计划.....14
（四）数据室请求清单.....15
附录：尽调底稿与访谈设计说明.....16

一、执行摘要：投资判断与交易要点

（一）核心建议：有条件推进

当前约 105 亿市值已包含大健康作为“渠道衍生品”的温和溢价。买方若以当前价格控股，其安全边际不依赖于基本盘的内生高增长，而在于大健康独立分拆套利或剥离流通、诊疗释放资本。建议以不高于 90-100 亿元的估值中枢设计交易结构，将大健康复购数据及少数股权谈判作为签署 Term Sheet 的前置条件。

（二）初步结论

有条件进入下一阶段评估，但不宜仅凭“老字号龙头+大健康高增长”的叙事给予成长型溢价。现阶段更适合将马应龙理解为“成熟 OTC 业务提供现金流与品牌底盘，大健康提供尚待验证的增长期权，业务组合与资本配置存在潜在优化空间”的复合型标的。

判断维度	当前判断	对交易的影响
核心治痔业务	品牌与零售渠道构成真实壁垒；2025 年销量增长显著快于收入增长，2026H1 毛利率承压信号需核实。	可作为现金流底盘，但不应将历史份额直接等同于未来定价权。
大健康业务	收入增长较快，但本质仍是依托原有 OTC 渠道网络的“渠道衍生品”，单品绝对收入、复购和投放 ROI 信息不足。	基准估值宜按关联健康消费业务定价，消费品牌溢价应由复购与独立渠道能力解锁。
业务组合	医药商业与医疗服务收入收缩、毛利率明显低于工业；是否剥离取决于独立利润、资产负担及买方协同。	“低毛利”不自动等于“低价值”；须用分部 EBITDA、营运资本、资本占用和处置成本验证。
资本配置	2025 年现金分红约 3.02 亿元（占归母 51.89%）；年末货币资金约 20.88 亿元，另有交易性金融资产约 5.06 亿元。	现金与分红提供回报缓冲，但不能将全部现金机械视为可分配净现金；需扣除经营现金需求及潜在负债。
交易可执行性	大健康由上市公司持股 48.48%但并表，少数股东权益比例 51.51-52%。	控制权交易需同步评估经济权益、治理安排、关联交易和少数股东整合成本。
退出与重估	分拆或引战是可选路径，不应作为基准情景的必然事件。	PE 回报模型应先验证不依赖分拆的回报，再把分拆、引战作为上行情景。

（三）交易立场

产业资本：优先评估渠道协同、核心产品组合、供应链与商业网络整合，以及大健康产品的渠道、品牌协同；不应先入为主地将流通与诊疗全部剥离。

PE：先按保守业务假设测算独立回报与分红回收，重点验证 EBITDA 质量、营运资本和可实现的经营改善；分拆估值切换不宜成为唯一退出路径。

（四）进一步尽调

马应龙的交易价值由三个层次共同决定：第一，核心治痔业务能否继续提供稳定且可预测的现金流；第二，大健康能否通过可重复的产品孵化、复购和渠道效率形成第二增长曲线；第三，买方能否在不破坏核心协同的前提下优化业务组合、资本配置和治理结构。当前公开信息

支持继续开展针对性尽调，但尚不足以支持无条件的成长型估值溢价。正式尽调的首要工作应是完成核心业务量价与库存核验、大健康单品经济性验证、分部财务拆分以及少数股东法律结构审查，再据此形成可执行的估值区间与交易建议。

二、标的信息与商业模式：现金流底座和业务组合

（一）公司定位：从肛肠药品龙头向健康方案提供商延伸

马应龙创立于 1582 年，历史上以眼药起家，后通过麝香痔疮膏、麝香痔疮栓等产品聚焦肛肠健康，并逐步向眼部护理、皮肤健康及其他大健康产品延伸。公司公开披露的战略方向，是由药品治疗向覆盖预防、保健、诊断、治疗、康复的全生命周期健康管理延展。2025 年年报披露，公司拥有百余个国药准字号药品及 200 余个大健康产品，产品组合包括肛肠健康、眼部健康及皮肤健康等。

战略转型可以被拆成三个层次，而不是笼统描述为“多元化”：第一层是核心治痔药品的深耕与关联延伸；第二层是围绕既有品牌、用户认知和渠道能力开发的非处方健康消费品；第三层是医药商业和医疗服务等业务网络。前两层可能共享品牌和消费场景，第三层是否形成经济协同，需要用客户流量、渠道采购、交叉销售及分部资本回报率证明。

（二）业务组合与盈利结构

业务板块	2025 年收入（亿元）	毛利率	同比收入变化	初步解读
医药工业	23.83	72.16%	+10.24%	主要利润来源；内部仍需区分治痔产品与其他产品。
医药商业	11.57	8.33%	-7.38%	规模大但毛利率低；须进一步核实 EBITDA、营运资本和独立经营必要性。
医疗服务	4.18	13.70%	-6.92%	收入收缩，需判断其是品牌、患者触点，还是资本回报偏低的独立业务。
大健康子公司	4.03	净利润约 0.50 亿元	约+30%	子公司口径收入，不宜与上市公司分行业口径直接相加；上市公司持股 48.48%，但并表。

注：前三项取自 2025 年年报主营业务分行业披露；大健康收入与净利润取自年报重要非全资子公司附注。各口径存在内部抵消及合并范围差异，不能直接相加作为合并营业收入。年报披露合并营业收入约 38.67 亿元，主营业务分行业合计口径约 38.16 亿元。

（三）财务快照与历史趋势

为了直观判断公司的现金流底座，需从历史长周期审视其盈利质量与资本开支。过去五年，公司经营现金流净额始终稳定在 5-6 亿区间，展现了极强的“现金牛”底色。但 2023 年逆周期资本开支（2.48 亿）与 2025 年分红率跃升（51.9%）值得关注，2025 年分红金额已逼近当期资本开支的 2.5 倍，说明管理层选择将现金流主要用于股东回报而非激进扩张。

核心指标（单位:亿元）	2021	2022	2023	2024	2025
营业收入	33.85	35.32	31.37	37.28	38.67
归母净利润	4.65	4.79	4.43	5.28	5.81
综合毛利率	40.40%	42.41%	41.91%	46.55%	49.19%
经营活动现金流净额	5.97	3.42	6.04	4.98	6.00

资本开支（CAPEX）	0.65	0.75	2.48	2.04	1.19
自由现金流（FCF）	5.32	2.67	3.56	2.94	4.81
现金分红	1.21	1.66	1.66	1.86	3.02
分红率	26.0%	34.7%	37.5%	35.2%	51.9%

（四）商业模式与核心资产

1、品牌资产：老字号历史、核心药品认知和肛肠细分定位，有助于降低消费者选择成本；品牌是否转化为定价权，要看实际成交价、渠道返利和竞品替代。

2、产品资产：核心膏、栓、眼部护理与皮肤药品等形成从治疗向护理的关联产品矩阵；产品数量多不等于品类经营能力成熟，应看新品存活率、单品贡献和复购。

3、渠道资产：零售药店与线上渠道并存。线上自营可提升用户数据可得性，但也带来流量成本、渠道冲突和价格体系管理问题。

4、制造与质量能力：公司披露拥有膏栓智能生产线及多品类生产资质；应进一步验证产能利用率、批次质量、委外比例、产品单位成本和扩产需求。

5、组织能力：公司披露围绕肛肠健康、眼美康、皮肤健康建立产线发展委员会；尽调需验证其是否对应独立 P&L、产品经理机制和预算责任制。

（五）口径注意事项

1、医药工业收入不等于治痔收入。2025 年治痔产品收入约 17.31 亿元，约占工业收入的 72.7%。

2、大健康子公司收入并非完全由上市公司股东享有。上市公司持股 48.48%，少数股东持股 51.51-52%，虽因治理安排并表，但经济利益分配不同。

3、合并报表中的货币资金不等于可自由分配的净现金，应区分货币资金、交易性金融资产、受限资金、经营所需现金、租赁及有息负债。

4、收入增长、出货增长和终端动销不是同一指标。尤其在渠道型 OTC 业务中，需同时核对厂家出货、终端销售、库存周转和退换货。

三、核心治痔业务：品牌壁垒仍在，增长质量需要重新定价

（一）业务底盘：高毛利、强品牌，但增长并非没有边界

2025 年治痔产品收入约 17.31 亿元，同比增长 8.75%，毛利率 73.60%。同年麝香痔疮膏销量同比增长 22.57%，麝香痔疮栓销量同比增长 18.03%。销量增速明显高于收入增速，意味着收入、销量的隐含单价或产品结构出现下移。该现象本身不能直接证明降价，因为规格、产品组合、渠道确认和销售节奏均可能影响结果，但它是本报告必须优先解释的量价背离。

2025 年膏剂库存量同比下降 55.75%，栓剂库存量同比增长 458.36%。库存方向分化说明不能仅凭单一 SKU 判断全渠道库存状态。厂家库存、经销商库存、零售终端库存和终端售出应分别核对；栓剂库存上升也可能与生产排期、季节性备货或销量基数有关，需取得月度序列后再判断。

（二）2026H1 的关键问题：终端转弱还是渠道、结构扰动？

2026H1 治痔终端产出“略有下滑”，治痔毛利率约 70.44%，同比下降 4.43 个百分点。特别需要警惕的是：2025 年报表显示应收账款和存货激增，导致净营运资本（NWC）占营收比升至 12.27%的历史高位。在“销量增速远超收入增速”的背景下，这极可能意味着渠道压货或库存滞销，2026H1 的终端下滑或许是渠道去库存的必然反噬。

可能原因	需要观察的证据	对投资判断的影响
终端需求走弱	终端动销、药店同店销售、处方、零售客流、竞品份额。	若趋势性放缓，核心业务的长期增长率和估值倍数均需下调。
渠道去库存	经销商库存天数、补货订单、退换货、厂家发货与终端销售差额。	若以去库存为主，短期波动不必全部外推至长期，但现金流和短期利润可能受影响。
渠道让利或价格结构变化	出厂价、终端成交价、返利、促销、产品规格结构、线上线下价差。	若收入增长依赖折扣，品牌壁垒可能未转化为利润保护。
NWC 异常（渠道压货、滞销）	应收、存货账龄、经销商退换货政策、期后回款情况。	若 2025 年高收入依赖向渠道压货，则 2026H1 及未来的真实动销能力将被重估。

（三）竞争壁垒的质量评估

核心产品的竞争力至少需要从四个维度验证：消费者端的品牌首选率和复购；药店端的货架覆盖、店员推荐率和单位货架产出；渠道端的库存周转、利润空间和商务政策；产品端的独家属性、质量稳定性与替代品可得性。公开材料中提及的“零售端约 50%份额”应核对统计范围、数据来源和时间区间，避免将局部渠道份额误认为全市场份额。

（四）集采与合规风险：不能将豁免作为基准假设

公开材料提示，马应龙核心治痔产品所用相关成分是否符合特定集采豁免条件，需要以产品注册资料、现行采购文件和监管口径逐项核实。在取得书面规则及专业法律、注册意见前，

不应将“可豁免”写入基准估值。

对集采的评估也不能简单等同于“是否降价”。至少应拆分：纳入概率、适用产品与规格、采购范围、价格降幅、约定采购量、渠道覆盖变化、零售端对非中选产品的反应，以及供应区域和履约要求。说明书合规是另一条独立风险线，应按注册合规项目管理，不与集采风险混为一谈。

（五）核心业务的估值含义

在渠道库存、终端份额和毛利率原因尚未验证前，建议以成熟 OTC 业务作为估值锚。基准情景应对收入增长、毛利率和费用率采用相对审慎的假设。

四、大健康第二曲线：渠道衍生品特征显著，消费品牌估值尚待证实

（一）增长规模：高增速有意义，但需区分规模与质量

根据 2025 年年报，马应龙大健康有限公司 2025 年营业收入约 4.03 亿元、净利润约 5013 万元。2026H1 大健康收入约 2.33 亿元、净利润约 3127 万元；按上年同期计算，收入同比增长约 25.3%，净利润同比增长约 11.8%。

大健康当前的快速增长，其本质是“依托马应龙原有数十万家药店终端和强大的肛肠品牌认知，进行的低成本渠道复用与衍生品变现”。卫生湿巾、眼霜等单品之所以能迅速放量，核心在于铺货逻辑（Sell-in），而非在纯消费品渠道（如商超、美妆集合店）打出的独立品牌力。因此，在脱离马应龙母品牌和药店渠道独立生存之前，它应被严格界定为“OTC 渠道衍生品”，而非“独立消费品牌”，不可直接套用珀莱雅等美妆、日化品牌的估值倍数。

（二）单品组合：从“明星产品”转向“品类经营能力”

尽调的关键在于验证公司是否具备可重复的产品孵化系统。只有当增长不再高度依赖个别爆品或母公司的强制铺货，才更有理由将其视为可复制的品类矩阵。

产品、方向	公开信息所支持的判断	关键特征问题
肛肠湿巾及卫生用品	增长极快（2026H1 同比超 100%），场景向日常清洁延展。	绝对收入、毛利率、复购率、渠道动销、退货率。
眼部护理、眼美康	2025 年增长较快，但 2026H1 受终端需求及运营调整影响下滑。	下滑是主动控投还是需求转弱；SKU 生命周期。
皮肤健康、龙珠软膏	具备药品品牌与健康消费场景延伸基础。	新渠道拓展、适用边界、消费者认知与复购。

（三）渠道与复购：自营占比不是复购质量的替代指标

线上自营占大健康线上业务比重超过 60%，湿巾进入数万家连锁终端及“老用户复购占比稳步抬升”出现方向性信号。自营渠道有利于掌握用户数据、价格与品牌表达，但同时会承担平台佣金、流量投放、履约、客服和退货成本。自营占比高并不必然意味着单位经济更好；必须将流量来源、投放成本、自然成交、复购频次和贡献毛利放在同一张表中分析。

建议指标	定义、拆解	判断用途
复购率	按首次购买月份分 cohort，分别计算 90、180、365 天复购；区分产品、渠道和新老客。	判断是否形成稳定消费习惯。
自然流量占比	自然搜索、直接访问、私域、会员与付费投放分别归因。	识别增长对平台买量的依赖。
获客成本与回收期	按渠道计算获客成本、首购贡献毛利及累计复购贡献毛利。	判断规模扩张是否创造经济利润。
单品贡献利润	收入扣除产品成本、平台费用、投放、履约、退货和可归属人员成本。	避免以销售额或毛利率替代真实盈利能力。
线下单店动销	有效铺货门店数、单店月销量、补货频率、库存天数、退货率。	区分渠道铺货与消费者真实购买。

价格与渠道冲突	线上线下同规格价格、促销频率、药店毛利和串货情况。	判断全渠道扩张是否损害线下推荐意愿。

（四）少数股权与治理：并表不等于享有全部经济权益

上市公司持有大健康 48.48%股权及表决权，少数股东持股 51.51-52%。2025 年大健康归属于少数股东的损益约 2559 万元。大健康子公司曾存在 2019 年期权计划及后续股份支付调整。该事项需调取激励计划原件、股东名册、股东协议等。不能一方面将大健康 100%利润作为集团价值基础，另一方面又忽略少数股东权益。

（五）大健康估值“升级”的证据门槛

1、阶段一：关联衍生业务（当前所处阶段）。依托母品牌和渠道，增长存在但复购、独立盈利尚不清楚。以可持续利润为基础，谨慎给予成长溢价（15-20xPE）。

2、阶段二：可复制的健康消费业务。多品类增长、复购 cohort 稳定、获客回收期可控。

3、阶段三：具备独立品牌资产属性。品牌认知、用户资产完全独立，才可讨论消费品牌可比估值与分拆溢价。

五、战略转型与资本配置：从多业务布局走向资源聚焦

（一）战略转型的实质：资源分配，而非业务标签变化

公司战略由核心药品向大健康延伸，方向上有品牌与场景的关联性；但转型是否创造价值，最终取决于资本、人力、渠道和管理注意力是否流向回报更高的业务。医药商业和医疗服务收入收缩，可能是聚焦的表现，也可能只是业务自然承压。必须核实收缩背后的主动决策、退出成本、资产减值和对核心业务的协同影响。

（二）低毛利业务是否应该剥离：用资本回报而非毛利率判断

医药商业 2025 年收入约 11.57 亿元、毛利率 8.33%；医疗服务收入约 4.18 亿元、毛利率 13.70%。这些指标显示其毛利率显著低于医药工业，但不能单凭毛利率判断其价值低。流通业务可能承担药店网络、渠道触达和销售履约功能；医疗服务可能提供患者教育、临床反馈和品牌触点。应分别测算独立 EBITDA、营运资本占用、维护性资本开支、租赁负债、资产减值、关联交易及与工业业务的协同收益。

选项	适用条件	潜在收益	主要风险
维持并优化	存在明显渠道协同，独立业务仍可达到合理回报。	维持网络触点，优化低效门店和运营成本。	改善幅度可能较慢，管理复杂度仍高。
区域整合、引入合作方	部分区域或资产具备协同，集团不必全资经营。	降低资本占用，保留关键渠道能力。	治理、利润分配和服务质量控制更复杂。
出售或剥离	业务可独立经营、协同较弱，且存在可实现的买方价值。	回收现金、简化报表、释放管理资源。	交易折价、税费、员工安置、合同转移、潜在减值。
保留为战略基础设施	虽单体回报不高，但对核心产品销售有可量化贡献。	保护核心渠道与患者触点。	需要以内部转移定价和 KPI 约束避免长期低效。

（三）现金、分红与再投资的权衡

2025 年归母净利润约 5.81 亿元，拟派现金红利约 3.02 亿元，分红比例 51.89%。经营活动现金流净额约 6.00 亿元。对产业资本而言，调整分红并非天然的价值创造。若存在高回报的产品孵化、渠道拓展或并购机会，将现金从分红转向再投资可能提高长期价值。

（四）研发与创新：投入比例之外看项目组合

2025 年研发费用约 7,811 万元，占营业收入约 2.0%。这一比例可作为历史基准，但不能单独判断研发投入不足或充足。需将研发项目按核心产品改良、循证研究、注册合规、创新药、新剂型及大健康产品功效评价分类，并对临床阶段、成功概率、预计投入、上市时间和商业化价值建立项目级回报框架。研发投入提升应与明确的技术、注册里程碑挂钩，而非仅作为战略转型的口号。

六、估值框架：整体 DCF、分部估值与交易价格

（一）估值原则：整体 DCF 用于校验，SOTP 用于解释价值来源

本估值模型以 2025 年末为基准日，采用 WACC8.5%、永续增长率 2.5%，预测 2026—2030 年收入增长率分别为 6.5%、8.5%、9.0%、7.5%和 5.5%，毛利率由 50.0%逐步升至 51.0%，销售费用率假设逐步改善。该模型可以作为起点，但目前假设隐含了集团收入持续增长、利润率温和改善及营运资本正常化等前提。考虑到业务板块增长差异、少数股东经济权益和业务组合调整，整体 DCF 不足以单独回答交易价值问题。

（二）对原 DCF 模型的关键审视

模型项目	现有处理、风险	建议修正
预测收入增长	2026—2028 年增长假设较为积极，且未充分区分工业、大健康、商业和医疗服务。	建立分部收入预测：核心治痔、其他工业产品、大健康、商业、医疗服务分别预测；显式列出销量、价格、结构与渠道假设。
毛利率	合并毛利率从 2025 年约 49.2%向 51%改善；分部变化可能被平均值掩盖。	拆分分部毛利率，分别设定成本、价格、产品结构和渠道折扣驱动因素。
销售费用率	集团费用率下降可能掩盖大健康投放强度上升。	将销售费用按业务分配；大健康单独建模获客成本、平台费、投放及履约成本。
营运资本	模型假设 2025 年营运资本异常增加、2026 年释放现金。	以应收、存货、应付周转天数建立预测；将一次性释放作为情景，不应未经验证直接计入基准价值。
税率	预测税率按 14.5%稳定处理。	核实各主体税收优惠、优惠期限、业务适用主体及大健康、其他业务税率差异。
少数股东权益	整体模型可能未充分反映大健康少数股东分流。	明确估值是企业价值还是股权价值；在 EV 到股权价值桥接中处理有息负债、现金、非经营性资产及少数股东权益。
终值	终值对 WACC 和永续增长率高度敏感。	至少给出 WACC×永续增长率敏感性矩阵，并检查终值占总价值比例及终值利润率合理性。
资本开支与折旧	稳态假设资本开支等于折旧摊销，可能低估扩张或维护需求。	区分维护性与扩张性资本开支，并结合产能利用率、生产线更新和增长计划校验。

（三）分部估值（SOTP）建议框架

SOTP 的目的，是把集团价值拆解为各业务的可持续经济利润和资本占用，而不是为每个板块机械套一个倍数。公开信息目前不足以支持精确的分部 EBITDA 加总，故本报告不提供伪精确的目标价。建议正式估值采用以下框架：

分部	建议方法	核心输入	关键调整
医药工业	可比公司 PE+分部 DCF	核心产品收入、毛利率、费用分摊。	集采、终端份额变化、量价背离。
大健康	分品类 DCF 或利润倍数交叉校验	单品收入与毛利、获客与复购 cohort。	少数股东权益、品牌依赖、单品集中度。
医药商业	独立 EBITDA 或处置情景	独立利润、营运资本、仓储物流资产。	低毛利、资本占用与协同损失。
医疗服务	单体现金流、资产基础法	单院收入、床位、医生资源。	持续亏损、合规及退出成本。

（四）估值情景与触发条件

情景	经营假设	价值逻辑	触发、否决条件
下行情景	核心治痔量价继续承压；毛利率无法修复；大健康增速显著放缓；商业、诊疗处置产生额外成本。	以成熟业务现金流和可回收资产为底，降低成长倍数并提高风险折价。	终端份额下降、库存累积、集采实质性降价、复购、ROI不达标。
基准情景	核心业务低个位数增长或温和恢复；大健康保持增长但尚未证明消费品牌属性；资本配置渐进优化。	以核心业务可持续利润定价，大健康给予有限成长溢价，现金按可用程度加回。	终端动销稳定、毛利率不再恶化、单品贡献利润及现金流可验证。
上行情景	核心业务份额与毛利率稳定；大健康多个品类形成可复制增长；获客回收期缩短；少数股权与治理问题可解决。	大健康估值从关联衍生业务向独立健康消费资产靠拢，业务组合优化兑现。	至少连续多个季度验证复购、自然流量、贡献利润和独立财务能力；分拆仅为可选项。

（五）综合估值区间定性判断（Football Field 逻辑）

虽然受限于分部财务数据的缺失，无法给出绝对精确的目标价，但基于整体 DCF、可比公司 PE（12-18x）以及 SOTP 的交叉校验，可得出以下定性估值区间：

当前市场定价（基准锚）：约 100-105 亿元（对应 2025 年静态 PE 17-18x，2026 年预测 PE 14-15x），已包含大健康作为“渠道衍生品”的温和溢价。

下行风险区间：80-90 亿元（对应 2025 年静态 PE 14-15x）。触发条件：集采实质性冲击核心产品、2025 年压货导致 2026 年报表剧烈去库存、大健康增速回落至个位数。

上行乐观区间：120-130 亿元（对应 2026 年预测 PE 17-20x，隐含估值切换）。触发条件：大健康复购与自然流量数据经证实（估值向消费品牌切换）、流通与诊疗业务成功剥离或优化、分红率进一步提升。

交易结论：马应龙的合理估值中枢在 100 亿元左右；买方若以当前市值（约 105 亿元）进行控股交易，其安全边际主要依赖于大健康的独立分拆套利或低效资产的快速剥离，而非基本盘的内生高增长。

（六）交易价格桥接：从上市公司市值到买方可支付价格

建议买方按以下顺序形成价格区间：市场基准；调整非经常性损益、超额现金；反映分部可持续利润及少数股东权益；评估控制权溢价与协同价值；扣除潜在税费和交易费用；按目标 IRR 反推最高报价。

七、交易策略：产业资本与 PE 的价值创造路径

（一）产业资本：以协同兑现和资源重配为主

价值杠杆	潜在举措	具体工作	关键 KPI
核心产品增长质量	按 SKU、渠道和地区拆分量价；重建终端动销与库存监控。	建立月度 sell-in、sell-out、库存三表，识别高毛利与高周转产品。	终端销售增长、毛利率、渠道库存天数、缺货、退货率。
大健康产品孵化	优先投资通过复购与单位经济验证的品类，建立新品阶段门。	逐 SKU 建 P&L 与 cohort，暂停无明确回报的低效投放。	复购率、自然流量占比、获客回收期、单品贡献利润。
渠道与供应链协同	利用现有药店网络、供应链与线上能力扩张有效品类。	核算药店单店产出与跨品类购买，厘清线上线下价格政策。	有效铺货门店、单店月销、补货率、渠道利润。
业务组合优化	对医药商业和医疗服务做独立回报评估，比较优化、合作与出售。	完成分部 EBITDA、营运资本、资本开支、租赁和处置成本审计。	ROIC、自由现金流、资本占用、处置净回款。
治理与激励	明确大健康经营责任、预算权、少数股东关系与关键人才留任。	核查股东协议和激励计划，建立管理层 KPI 与增量激励。	预算达成率、核心人才留任、经营现金流与利润质量。

（二）PE：先建立不依赖分拆的回报模型

PE 的投资逻辑应以持有期内可验证的经营改善和现金回收为基础。高分红可能支持持有期现金回收，但不能替代退出估值和债务偿付能力分析。若以公开市场上市公司控股权为目标，还需分析交易审批、收购资金来源、控制权变更后的业务整合边界、上市公司治理和关联交易约束。

1、基准回报：假设核心业务保持成熟企业增长、大健康仅获得有限成长溢价、业务组合优化按保守时间表执行。

2、经营改善回报：将成本、营运资本、渠道动销和新品经济性改善逐项量化，避免把“协同”作为无金额的口号。

3、资本结构回报：对可用现金、分红、融资成本和可能的债务结构变化建模；不可把账面现金全部视为可用于杠杆收购的资金。

4、退出回报：至少设置 IPO、分拆、产业买方出售、公开市场减持、退出等路径，并为分拆失败或延迟设置替代方案。

（三）交易结构的可选路径

路径	优势	核心障碍	需确认事项
收购上市公司控制权	可统筹核心业务、资本配置与大健康战略。	控制权溢价、公众公司治理、监管与信息披露、少数股东权益。	控制权取得方式、股权结构、收购资金、重大事项审批、关联交易。
大健康引入战略投资者	资金与能力直接进入增长业务，可能提升治理与市场化运营。	上市公司持股比例、估值公允性、关联交易、控制权和未来退出安排。	子公司章程、股东协议、优先权、董事席位、增资稀释机制。

大健康分拆上市、独立资本化	有机会形成独立估值锚并增强激励。	监管条件、财务独立性、资产、净利润比例、关联交易和少数股东安排。	最新分拆规则、净资产口径、独立业务和人员、历史募集资金使用。
业务出售或合作	聚焦核心、回收资金并降低管理复杂度。	潜在买方范围、价格、合同转移、税费、员工与协同损失。	分部独立财务、资产权属、客户合同、潜在负债和处置费用。

注：上述路径是交易选项，不代表公司已启动相关计划。尤其是分拆，应以届时有效监管规则、最新审计财务数据及专业法律意见为准；本报告不将其视为必然退出事件。

八、关键风险、证伪条件与正式尽调计划

（一）风险矩阵

风险	当前判断	估值、交易影响	验证方式
核心治痔业务量价背离	已出现公开数据线索，原因未明。	收入增长、毛利率和核心业务估值倍数可能下调。	SKU 量价桥、渠道库存、终端动销、返利与竞品访谈。
集采及注册合规	规则适用性和产品注册状态需核实。	可能导致价格、渠道或供应要求变化；合规整改可能增加费用。	采购文件、注册资料、法规顾问书面意见、公司整改计划。
大健康单品集中与投放依赖	增长较快，但单品绝对收入、复购和 ROI 未完整公开。	消费品估值溢价可能无法兑现，增长费用侵蚀利润。	单品 P&L、平台后台、投放归因、复购 cohort、线下动销抽样。
少数股东权益与期权计划	经济权益和控制权不完全一致。	估值需扣除少数股东权益，交易、分拆执行成本增加。	股东名册、章程、股东协议、期权文件、法律尽调。
业务剥离与资产减值	流通、诊疗收入收缩，但独立盈利和协同未充分披露。	出售价格低于账面预期，产生税费、减值和一次性成本。	分部资产负债表、现金流、门店、医院单体模型、合同清单。
资本配置错配	现金充裕、分红较高，新增投资回报信息不足。	过度分红可能限制增长；过度投资也可能造成资本损失。	现金可用性、项目 IRR、并购历史、资本开支计划。
估值模型偏差	分部预测、营运资本和少数股东权益需进一步完善。	整体 DCF 可能高估终值或重复计入子公司价值。	重建分部模型、敏感性分析、EV-Equity 桥接、模型审计。

（二）证伪条件：出现哪些事实应下调或终止投资判断

1、若核心治痔终端动销连续多个季度低于行业、竞品，且渠道库存并非短期去化所致。

2、若毛利率下降主要由持续渠道让利、价格竞争或产品结构恶化驱动。

3、若大健康收入增长高度依赖付费投放，复购 cohort 不改善或单品贡献利润为负。

4、若少数股东协议含实质性否决权、且无法在可接受成本下解决。

5、若流通、诊疗剥离导致核心业务渠道成本上升，或处置需承担重大负债及减值。

6、若模型价值主要来自终值，且在合理 WACC 上升情景下回报低于门槛。

（三）正式尽调工作计划

工作流	第一优先级资料	核心分析产出	建议责任方
商业、市场	产品级销量、收入、价格、渠道、终端动销、竞品数据；药店与经销商名单。	市场份额、量价桥、渠道库存、竞争定位、增长预测。	商业尽调、行业专家
财务	月度管理报表、分部 P&L、费用分摊、应收、存货、应付账龄、现金流、资本开支。	正常化 EBITDA、营运资本、现金转换、分部 ROIC、质量收益分析。	财务尽调、会计师
大健康增长质量	单品 P&L、渠道数据、投放后台、用户 cohort、退货、折扣、会员复购。	单品经济模型、新品成功率、复购和获客回收期、独立估值。	商业尽调、数字营销专家
法律、治理	子公司章程、股东协议、历史增资、期权计划、关联交易、知识产权。	少数股权权利图谱、交易限制、激励与整合方案。	法律顾问
税务、合规	税收优惠、药品注册、集采文件、广告宣传、产品质量、诉讼及行政事项。	税务调整、合规风险清单、整改成本与交易保护条款。	税务、法规顾问

交易与估值	股本与股东结构、市场行情、融资条款、可比交易、退出路径。	SOTP、DCF、回报模型、报价区间、交易结构和敏感性。	交易团队、估值团队

（四）数据室请求清单

1、第一优先级：直接影响估值的资料

（1）2023—2026 年按月、按 SKU、按渠道的收入、销量、出厂价、折扣返利、退货和毛利数据（重点查 2025 年压货情况）。

（2）治痔产品厂家出货、经销商库存、终端销售和库存周转天数。

（3）应收账款账龄分析、存货库龄分析及期后回款情况。

（4）大健康各单品 2024—2026H1 收入、成本、毛利、投放、平台费、履约、退货、贡献利润及费用分摊规则。

（5）湿巾、眼部护理及皮肤健康的复购 cohort、自然、付费流量占比、获客成本、客单价、投放回收期。

（6）医药商业、医疗服务分部的独立利润、资产负债表、现金流、资本开支、门店、医院单体数据。

2、第二优先级：直接影响交易结构的资料

（1）大健康股东名册、章程、股东协议、历史增资文件、董事会、股东会决议、优先权及退出安排。

（2）2019 年期权计划完整文件、授予、行权、失效台账、股份支付会计处理、激励对象与现有股东重合情况。

（3）关联交易清单、母子公司间品牌、商标、研发、渠道、人员、资金安排及定价政策。

（4）现金与金融资产明细、受限资金、债务、担保、诉讼、税务风险及或有负债。

3、第三优先级：直接影响长期战略判断的资料

（1）公司未来 3—5 年战略规划、预算、研发项目清单、新品上市计划、产能与供应链计划。

（2）核心药品集采及注册合规专项说明、监管沟通记录、整改里程碑与预计成本。

（3）资本配置政策、分红安排、并购筛选标准、历史投资项目回报复盘。

附录：尽调底稿与访谈设计说明

关于 DCF 估值与敏感性测算，本人在准备阶段已基于公开信息独立搭建了完整的底稿模型（包含 NWC 异常释放、WACC 8.5%等假设）。但在实际推演中，DCF 算出的绝对估值与当前市场定价存在显著背离，这恰好印证了市场对“渠道压货”及“少数股权截留”给出了极大的风险折价。因此，本报告在正文中舍弃了 DCF 的绝对数值，转向更为务实的定性估值区间（Football Field 逻辑）与 SOTP 交叉校验。

为了验证前述核心假设，本人针对管理层、渠道商及行业专家设计了三级深度访谈提纲（详见后续页面）。具体的访谈目标与验证逻辑如下表所示：

访谈对象、模块	核心问题	对应章节	访谈目标与需要取得的证据
管理层：核心业务量价	销量增速显著高于收入增速的原因；终端下滑的主导因素；库存与毛利率归因。	第三章	获得价格、结构、返利桥、月度终端动销和库存天数；核实 2025 年是否存在向渠道压货。
管理层：大健康单品	湿巾收入占比、眼美康调整原因、龙珠软膏定位、复购与买量比例。	第四章	取得单品绝对收入、贡献利润、复购 cohort、投放 ROI 及单店动销；论证其脱离药店渠道的独立生存能力。
管理层：少数股权与激励	少数股东构成、2019 年期权执行状态、分拆、引战障碍。	第四章、第七章	核对股东名册、期权台账、股东协议、优先权及潜在治理约束。
渠道商：核心药品动销	门店排名、竞品替代、库存周转、供货政策。	第三章	三类渠道交叉验证，重点核实是否存在强制搭售或压货行为。
行业专家：估值、交易	消费健康估值、少数股权折价、控制权溢价及投后价值杠杆。	第六章、第七章	为交易结构与估值假设提供外部校验。

马应龙 CDD 项目专家访谈提纲

一、管理层访谈（90 分钟）

访谈对象：3-5 人（董事、财务、总经理、核心业务营销负责人、大健康业务负责人）

【基本盘】增长与量价 1-3、毛利率 4-5、集采与政策 6-8、竞争格局 9-10

1、2025 年治痔收入+8.75%，但膏/栓销量增速在 18%-22%。管理层是如何看待这种“销量增速大幅高于收入增速”的现象？内部认为背后的核心驱动因素是什么？

（1）这种情况是在我们的预期和规划之内的，还是说终端确实发生了一些我们不愿意看到的让利或结构变化？

2、2026H1 治痔终端产出“略有下滑”，而 2025 年还是高增长。从管理层的视角来看，过去这半年终端到底发生了什么？是什么导致了转折？

（1）如果在零售大环境、渠道库存和竞品动作这三个因素里排个序，您觉得哪个是主导？

3、渠道库存方面，2023 年痔疮膏库存曾降到 92 万支。目前我们渠道端的库存水位和周转天数，处在一个什么样的真实状态？

4、2026H1 治痔毛利率 70.44%（同比-4.43pct），管理层认为这是偶发波动，还是趋势性拐点？内部财务归因是什么？各项影响权重的大致排序是怎样的？

5、我们留意到中药材价格近期有所回落。在这个背景下，下半年我们的毛利率有没有可能迎来一个改善的拐点？影响这个拐点的主要变量是什么？

（1）如果毛利率仍在承压，是否意味着我们在终端提价的空间受到了限制？

6、对于核心治痔产品被纳入集采这件事，公司内部目前的研判是怎么样的？

（1）在应对集采风险上，目前做了哪些实质性的准备？

7、集采规则里有个“双天然”的豁免口径。在实际操作中，我们麝香痔疮膏/栓的产品成分属性，能不能享受到这个政策缓冲？这直接关系到对尾端风险的评估。

8、关于中药说明书不良反应“尚不明确”的注册合规要求，目前我们核心产品的合规整改推进到哪一步了？预计什么时间点能彻底解决？

9、零售端约 50%的份额，内部怎么看这个份额的稳固程度？过去三年，竞品（比如荣昌肛泰或迈之灵）在终端打法上的新动作是否让管理层感觉到压力？

10、马应龙 1-2 元/天的低价定位，在现在的药品价格治理环境下，管理层认为这个定价策略对我们是更偏向于保护，还是更偏向于束缚？内部对提价有过怎样的讨论？

11、长期看，痔疮发病率虽然高，但患者就医和用药的渗透率似乎在受微创手术和生活方式影响。管理层怎么看未来 5 年整个痔疮用药盘子的自然增长性？我们是不是在做大单品的衍生

（比如湿巾），去对冲膏/栓品类的潜在萎缩？

【大健康】增长质量 11-13、复购与渠道 14-16、少数股权与激励 17-20

12、湿巾 2026H1 增速超 100%，表现非常亮眼。能否分享一下它在整个大健康板块里的营收占比情况？

（1）它在今年上半年的增量贡献里大概占了几成？

13、眼美康从 2025 年的高增长，到 2026H1 转负。管理层提到的“终端需求和运营模式调整”，具体是指我们在主动挤水分（如减少买量），还是消费端真的降温了？ 预计何时能重回正轨？

14、如果剔除掉湿巾和眼美康，大健康剩下的业务盘子，目前增速如何？龙珠软膏这样的皮肤类药品，内部对它未来的定位是什么？认为它是否有潜力成为下一个接棒的核心单品？

15、中报提到“老用户复购占比稳步抬升”，这个“抬升”是建立在多大基数上的？湿巾和眼霜的具体复购率，目前大概在什么水平？

（1）线上自营渠道（占比超 60%）的复购频次，比第三方分销渠道高出多少？

16、湿巾目前进了数万家连锁终端。从后台数据看，单店的动销水位和经销商库存周转，跟传统的药品比，呈现出什么不同的特征？

17、目前大健康的线上增长中，买量驱动的短期转化和自然复购驱动的长期贡献，大概是一个什么样的比例？

18、大健康子公司目前 51-52%的少数股权结构，在后续的资本运作中比较关键。这部分少数股东主要由哪些群体构成？他们当初入股的背景是什么？

19、2019 年设立的期权计划，目前的执行和行权状态是怎样的？当时的激励对象，跟现在的少数股东名单重合度高吗？

20、从推进大健康分拆或引战的可行性角度，目前的少数股权结构或历史协议中，是否存在需要提前解决的治理障碍？具体条款我们在数据室阶段核对，现在只想了解障碍的性质。

21、上市公司层面一直没做股权激励。内部是出于什么样的治理考量？还是说目前的薪酬与分红机制，已经足以保障团队的战斗力？

【资本配置】分红与再投资 21-23、流通与诊疗的处置 24-25、战略优先级 26-27

22、公司明确了 70%的分红下限，在什么触发条件下（如极好的大健康并购机会），公司会考虑调整这个下限去进行再投资？内部如何平衡短期股东回报和长期转型投入？

23、公司账上有 20 多亿净现金。管理层一直保持这么高的现金储备，且没有进行大规模并购，背后的战略考量是什么？是在等更好的标的，还是坚持内生增长？

24、研发费用率目前在 2%左右。随着虎麝三期临床等项目推进，未来几年研发投入的强度会

有系统性的变化吗？

25、医药流通和医院诊疗这两块业务近两年都在收缩。这个战略收缩的终点在哪里？是保持现状，还是最终会彻底剥离？

26、这两块业务目前的资产减值风险大吗？如果未来要处置，内部的合规和审批障碍主要在哪里？

27、之前公开提到大健康分拆是“当板块做到较大规模时”。在管理层的内部 KPI 或心理预期中，这个“较大规模”有没有具体的量化门槛？

28、抛开具体的财务指引，就管理层目前的体感而言，下半年的经营环境和上半年比，是会更困难，还是随着中药材成本回落会有喘息空间？

二、渠道商访谈（30 分钟）

访谈对象：6-10 家（大型连锁药店、中小连锁/单体药店、代理商/经销商、线上代运营/电商平台）

【治痔药品的终端动销】

1、马应龙在店里的地位，和 5 年前比是变强了还是变弱了？如果排名，马应龙排第几，后面的竞品是谁？”

2、过去 12 个月，马应龙膏/栓在这里的动销情况如何？跟其他痔疮药（比如肛泰）比，是跑赢了还是跑输了？

3、跟店里其他同类的药比，马应龙的库存周转是快还是慢？厂家要求的安全库存大概是多少？

4、马应龙在店里的商务政策，和肛泰这些竞品比，公开的供货折扣或返利安排大概是什么水平？厂家提供的店员培训和促销物料支持，频率和力度跟竞品比有明显差异吗？

5、过去三年，马应龙的供货价和零售价有没有什么变化？您觉得卖马应龙的利润空间是变大了还是变小了？

6、如果未来马应龙的核心药进了集采，您觉得对药店的生意会有什么影响？还愿意继续推马应龙吗？

【大健康单品渠道】

7、马应龙现在推的湿巾，在店里卖得怎么样？一个月大概能走多少量？买湿巾的人，是顺便买药，还是专门来买湿巾的？复购情况怎么样？

8、湿巾的库存周转，跟马应龙的痔疮膏比，哪个快？有没有出现压货现象？

9、今年上半年眼霜/眼美康的动销情况如何？

（1）下滑是因为消费者不买了，还是因为厂家自己改了运营策略，比如线上自己卖了？

10、龙珠软膏最近卖得好吗？买的人是当药买，还是当护肤品买？您认为有没有向护肤品转化的潜力？

11、现在马应龙自己在线上搞直播卖湿巾和眼霜，您感觉这对咱们线下的生意影响大吗？顾客会因为线上便宜，来店里试了再去网上买吗？

【对马应龙战略感知】

12、您感觉马应龙这两年推新品的节奏、给的政策，跟以前比有什么明显的不一样吗？

13、从渠道商的角度，马应龙如果要进一步做大零售终端，您觉得厂家最应该优先改善的是哪个环节？

三、行业专家（60 分钟）

访谈对象：3-5 人（医药政策/集采专家、OTC/中药行业前高管、大健康赛道投资人、投行/法务专家）

【中药 OTC 行业与集采】

1、第四批中成药集采规则里，“双天然”（天然牛黄/麝香）的豁免条款，在实操中到底卡得有多严？人工麝香是不是绝对不适用？

2、对于零售终端占绝对主导的 OTC 独家品种，在集采谈判中通常能争取到什么样的差异化处理？降幅中枢与院内品种有何不同？

3、您怎么看过去三年马应龙这 50%的零售份额？是被谁在慢慢啃食，还是其实壁垒比外界想的要深？

4、痔疮用药市场大概 58 亿的规模，增速 5%左右。您认为未来 3-5 年，这个市场的核心增长逻辑是什么？天花板在哪里？

【消费健康与大健康的估值逻辑】

5、假设有一家传统中药企业，主药增长停滞，但旗下有一块占营收大概一成的日化/大健康业务，增长很快，但上市公司持股不到一半。您平时看这类公司，大健康这块怎么估值？

6、您看过的消费品案例里（比如云南白药牙膏），药品衍生的日化产品，要满足什么硬性指标（比如复购率、自营占比达到多少），资本市场才会真正把它当消费品来估值？

7、假设一家医药上市公司的大健康子公司，母公司持股不到一半（比如 45%-50%区间），在 A 股分拆或引入战投时，少数股权的处理通常有哪些结构性的坑？折扣率一般怎么算？

8、在当前的 A 股分拆审核中，针对少数股权结构和母子公司之间的关联交易，监管审核的尺度大概是怎样的？有没有类似体量的成功先例可以参考？

【交易与估值】

9、中药 OTC 企业的控制权交易，目前市场能接受的 EV/EBITDA 中枢大概在多少？控制权溢价通常给多少？

10、产业资本和 PE 买中药企业，投后的“三板斧”通常是什么？在马应龙这个案子上，您觉得哪一斧（比如剥离低效资产、大健康分拆、调整分红）最能立竿见影地创造价值？